# DIRD

Detección de Retinopatía Diabética

## INFORME FINAL

Generado: 25/12/2025 12:18:41

## INFORMACIÓN CLÍNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre** | Paciente Demo | **Fecha** | 15/10/2025, 12:00:00 |
| **ID de Paciente** | DEMO-001 | **Sesión** | N° 1 |
| **Edad** | 45 años | **Modelo** | DIRDv1r1 |
| **Antecedentes** | Diabetes type2 (10a), HTA, DLP, Meds: Metformina 850mg, Enalapril 10mg, Atorvastatina 20mg, Otros: Paciente de demostración para propósitos educativos y de prueba del sistema DIRD. | | |
| **Nota Sesión** | Sesión de control inicial. Se observan múltiples lesiones que requieren seguimiento. Esta sesión está finalizada y sirve como referencia para comparaciones. | | |

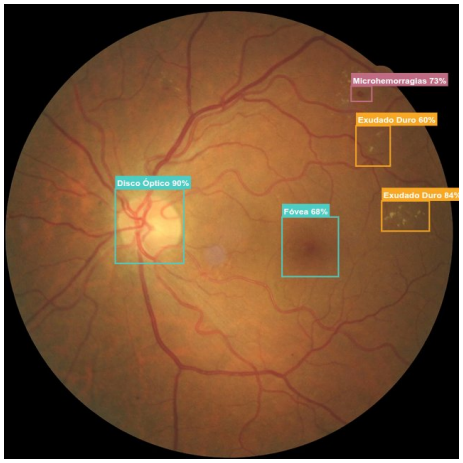
## Detecciones

| Tipo | Resultados |
|---|---|
| Disco Óptico | 4 |
| Exudado Duro | 6 |
| Microhemorragias | 5 |
| Fóvea | 4 |

## Galería de Imágenes

### OI (Izquierdo)

OI-1.png




Hallazgos: 5

### OD (Derecho)

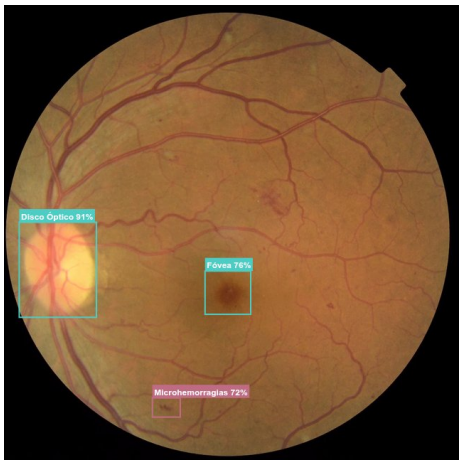
OD-1.png




Hallazgos: 6

## OI (Izquierdo)

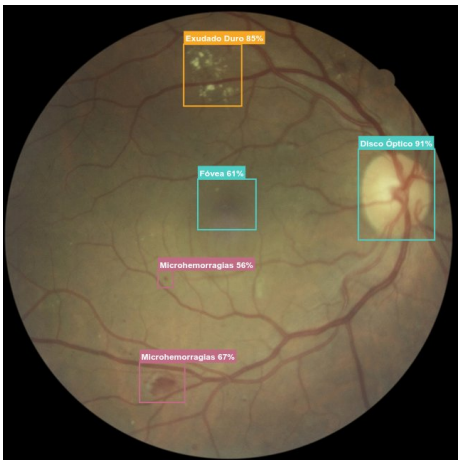
OI-2.png




Hallazgos: 3

## OD (Derecho)

OD-2.png




Hallazgos: 5

## Notas del Evaluador (Opcional)

EVALUACIÓN OFTALMOLÓGICA - SESIÓN DE CONTROL INICIAL

Paciente de 45 años con diabetes mellitus tipo 2 de 10 años de evolución, hipertensión arterial y dislipidemia. Se presenta para evaluación de fondo de ojo de rutina.

HALLAZGOS PRINCIPALES:

Ojo Derecho (OD):
- Disco óptico de bordes definidos, excavación fisiológica
- Mácula sin edema evidente
- Presencia de exudados duros en región temporal y nasal
- Microhemorragias dispersas en polo posterior
- Relación arteria/vena conservada

Ojo Izquierdo (OI):
- Disco óptico sin alteraciones significativas
- Fóvea preservada
- Exudados duros en cuadrante temporal superior
- Microhemorragias aisladas
- Vasculatura retiniana sin tortuosidad importante

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA:
Retinopatía diabética no proliferativa leve a moderada bilateral

RECOMENDACIONES:
1. Control estricto de glucemia (HbA1c objetivo <7%)
2. Optimización de control de presión arterial
3. Continuar con estatinas para control lipídico
4. Seguimiento oftalmológico en 4-6 meses
5. Educación sobre importancia de adherencia al tratamiento
6. Considerar derivación a endocrinología si mal control metabólico

PRÓXIMA EVALUACIÓN:
Se recomienda control en 6 meses o antes si aparecen síntomas visuales. Informar al paciente sobre signos de alarma (pérdida súbita de visión, moscas volantes, destellos luminosos).

Firma del Especialista